Fondements et cadres

FACILE

Q01 · Quelles propositions caractérisent un entretien infirmier ?

- [ ] A. Il vise à empêcher le patient d'exprimer ses préoccupations.
- [ ] B. Il exclut la fixation de tout objectif soignant.
- [ ] C. C'est un soin relationnel.
- [ ] D. C'est nécessairement une conversation sans objectif.
- [ ] E. Il correspond toujours à un interrogatoire standard.

1 réponse attendue

FACILE

Q02 · À quoi reconnaît-on surtout un entretien formel ?

- [ ] A. Ses objectifs sont définis et annoncés.
- [ ] B. Il ne peut jamais réunir plusieurs personnes.
- [ ] C. Il est programmé.
- [ ] D. Il est nécessairement non directif.
- [ ] E. Le lieu et la durée doivent rester inconnus jusqu'à la fin.

2 réponses attendues

FACILE

Q03 · Quelles situations peuvent conduire à un entretien informel ?

- [ ] A. Une crise d'angoisse interdit de proposer un entretien.
- [ ] B. Toujours un rendez-vous prévu plusieurs semaines avant.
- [ ] C. Uniquement une convocation écrite.
- [ ] D. Une demande inattendue du patient.
- [ ] E. La rencontre ne peut survenir à la demande spontanée du patient.

1 réponse attendue

MOYEN

Q04 · Comment classer un entretien selon les participants ?

- [ ] A. Familial.
- [ ] B. Semi-directif.
- [ ] C. Directif.
- [ ] D. Individuel.
- [ ] E. Formel.

2 réponses attendues

MOYEN

Q05 · Quelles distinctions entre catégories sont correctes ?

- [ ] A. Formel/informel renseigne sur l'organisation.
- [ ] B. Informel signifie nécessairement non directif.
- [ ] C. Directif/semi-directif renseigne sur la technique.
- [ ] D. Familial signifie nécessairement formel.
- [ ] E. Individuel/familial renseigne sur les participants.

3 réponses attendues

FACILE

Q06 · Parmi ces éléments, quels sont des objectifs possibles d'un entretien infirmier ?

- [ ] A. Obtenir une obéissance inconditionnelle.
- [ ] B. Apporter un soutien.
- [ ] C. Éviter toute interaction avec la personne.
- [ ] D. Recueillir des données.
- [ ] E. Favoriser un changement souhaité.

3 réponses attendues

MOYEN

Q07 · En quoi l'entretien diffère-t-il d'une simple conversation ?

- [ ] A. Il peut s'appuyer sur un objectif défini.
- [ ] B. Il exclut l'écoute de la personne.
- [ ] C. Il impose de ne jamais ajuster les questions pendant l'échange.
- [ ] D. Il impose toujours uniquement des questions fermées.
- [ ] E. Il suit une finalité de soin.

2 réponses attendues

MOYEN

Q08 · Une rencontre non prévue pour répondre à une question ciblée sur un médicament peut être…

- [ ] A. Informelle.
- [ ] B. Sans aucun objectif parce qu'elle n'était pas prévue.
- [ ] C. Un entretien informatif.
- [ ] D. Nécessairement familiale.
- [ ] E. Plutôt directive selon la conduite retenue.

3 réponses attendues

DIFFICILE

Q09 · Quelles affirmations reflètent une conduite souple des différents types d'entretien ?

- [ ] A. La technique se déduit uniquement du lieu.
- [ ] B. Dans un entretien infirmier, l'échange conserve une finalité de soin.
- [ ] C. Les catégories d'entretien sont des repères et non des cases toujours exclusives.
- [ ] D. La liste des objectifs est présentée comme forcément exhaustive.
- [ ] E. Un entretien peut mêler information et recadrage.

3 réponses attendues

DIFFICILE

Q10 · Quelles précautions sont adaptées lors d'un entretien familial ?

- [ ] A. Considérer que tous les propos intimes sont automatiquement communicables.
- [ ] B. Identifier le but de la rencontre.
- [ ] C. Se dispenser d'écouter le patient parce que la famille est présente.
- [ ] D. Vérifier la place de la personne soignée.
- [ ] E. Adapter les échanges au cadre professionnel.

3 réponses attendues

Techniques de conduite

FACILE

Q11 · Quels éléments caractérisent l'entretien directif ?

- [ ] A. Une liste de questions préparées.
- [ ] B. L'absence de but précis.
- [ ] C. Il exclut totalement l'usage de questions fermées.
- [ ] D. Un discours du patient constamment libre et ininterrompu.
- [ ] E. La thématique est toujours inconnue du soignant.

1 réponse attendue

MOYEN

Q12 · Quels outils peut-on employer dans un entretien directif ?

- [ ] A. Absence de préparation de toute question.
- [ ] B. Silence prolongé comme unique méthode.
- [ ] C. Il exclut par définition toute utilisation de grilles ou d'audits.
- [ ] D. Questionnaire.
- [ ] E. Grille.

2 réponses attendues

FACILE

Q13 · Dans un entretien semi-directif, que retrouve-t-on ?

- [ ] A. Des questions ouvertes possibles.
- [ ] B. Des thèmes pré-définis.
- [ ] C. Il interdit toute parole spontanée du patient.
- [ ] D. Une obligation de suivre mot pour mot un questionnaire fermé.
- [ ] E. Une interdiction de relancer.

2 réponses attendues

MOYEN

Q14 · Quelles propriétés caractérisent le non-directif ?

- ☐ A. Un cadre d'exploration posé par le soignant.
- ☐ B. Une expression plus continue du patient.
- ☐ C. La nécessité de maîtriser l'écoute active.
- ☐ D. Uniquement des questions fermées.
- ☐ E. L'absence complète d'objectif.

3 réponses attendues

FACILE

Q15 · Quelle formulation est une question ouverte ?

- ☐ A. « Avez-vous dormi ? »
- ☐ B. « Est-ce que vous fumez ? »
- ☐ C. « Comment vivez-vous le traitement ? »
- ☐ D. « Avez-vous pris votre traitement ? »
- ☐ E. « Avez-vous mal ? »

1 réponse attendue

MOYEN

Q16 · Quelle formulation convient à un recueil ciblé sur la consommation tabagique ?

- ☐ A. « Ne répondez pas si vous le souhaitez, mais je cocherai oui. »
- ☐ B. « Fumez-vous actuellement ? »
- ☐ C. « Racontez toute votre enfance. »
- ☐ D. « On sait que vous mentez sur le sujet. »
- ☐ E. « Vous ne fumez pas, n'est-ce pas ? »

1 réponse attendue

MOYEN

Q17 · Pourquoi un guide de thèmes peut-il être utile au semi-directif ?

- ☐ A. Il supprime tout objectif de soin dès qu'une question est ouverte.
- ☐ B. Il remplace entièrement l'écoute active.
- ☐ C. Il aide à ne pas oublier des points importants.
- ☐ D. Il interdit toute adaptation à l'échange.
- ☐ E. Il interdit de laisser le patient développer une réponse.

1 réponse attendue

DIFFICILE

Q18 · Dans un entretien plutôt non directif, le soignant doit…

- [ ] A. Accueillir un discours qui se développe.
- [ ] B. Savoir recentrer au besoin.
- [ ] C. Éviter systématiquement toute reformulation.
- [ ] D. Garder en tête une finalité.
- [ ] E. Ne jamais observer le non-verbal.

3 réponses attendues

MOYEN

Q19 · Comment distinguer question ouverte et question fermée ?

- [ ] A. Une question fermée est toujours maltraitante.
- [ ] B. Le type de question est choisi sans tenir compte du but.
- [ ] C. Une question ouverte supprime l'objectif de soin.
- [ ] D. Une question ouverte favorise le développement d'un point de vue.
- [ ] E. Une question fermée sert parfois à obtenir une donnée précise.

2 réponses attendues

DIFFICILE

Q20 · Quelles précautions évitent de transformer un non-directif en discussion sans cadre ?

- [ ] A. Proscrire les silences.
- [ ] B. Poser un sujet d'exploration.
- [ ] C. Interrompre dès qu'un sujet nouveau apparaît.
- [ ] D. Conserver les objectifs de soin.
- [ ] E. Maintenir l'écoute.

3 réponses attendues

Objectifs des entretiens

FACILE

Q21 · Dans l'entretien d'accueil initial, quels éléments sont pertinents ?

- [ ] A. Se limiter à énumérer les horaires du service.
- [ ] B. Écarter systématiquement tout recueil de données sur la personne.
- [ ] C. Créer de la confiance.
- [ ] D. Ne jamais évaluer les besoins du patient.
- [ ] E. Refuser les questions du patient.

1 réponse attendue

DIFFICILE

Q22 · À propos de l'entretien d'accueil et de la phase d'accueil, quelles affirmations sont exactes ?

- [ ] A. L'entretien d'accueil est un type d'entretien.
- [ ] B. La phase d'accueil appartient au début de tout entretien.
- [ ] C. Toute phase d'accueil doit comporter un recueil de données intégral.
- [ ] D. L'ouverture vise notamment la présentation et le cadre.
- [ ] E. Les deux expressions sont parfaitement synonymes.

3 réponses attendues

FACILE

Q23 · Que peut comporter un entretien informatif ?

- [ ] A. Une annonce sans dialogue possible.
- [ ] B. Il évite systématiquement de parler des traitements.
- [ ] C. Une certitude que la personne a tout compris sans vérifier.
- [ ] D. Une réponse aux questions du patient.
- [ ] E. Des explications sur les soins.

2 réponses attendues

MOYEN

Q24 · Quels éléments caractérisent les soins éducatifs ?

- ☐ A. Compléter l'information.
- ☐ B. Supposer que toute explication suffit.
- ☐ C. Évaluer des connaissances préalables.
- ☐ D. Accompagner un apprentissage de geste.
- ☐ E. Exclure les questions du patient.

3 réponses attendues

FACILE

Q25 · Quels principes soutiennent un entretien d'aide ?

- ☐ A. Il impose de porter un jugement sur le vécu de la personne.
- ☐ B. Décision systématique à sa place.
- ☐ C. Empathie.
- ☐ D. Étiquetage de la personne.
- ☐ E. Porter systématiquement des jugements de valeur.

1 réponse attendue

MOYEN

Q26 · Parmi ces outils, lesquels sont nommés pour l'entretien d'aide ?

- ☐ A. Moquerie.
- ☐ B. Reformulation.
- ☐ C. Menace.
- ☐ D. Il consiste à accuser le patient au lieu de l'écouter.
- ☐ E. Clarification.

2 réponses attendues

MOYEN

Q27 · Face à une personne qui exprime une inquiétude profonde, quelles réactions sont compatibles avec la relation d'aide ?

- ☐ A. Éviter de juger son émotion.
- ☐ B. Laisser la personne exprimer son vécu.
- ☐ C. Chercher à comprendre sa préoccupation.
- ☐ D. Lui interdire d'évoquer ce qui lui fait peur.
- ☐ E. Répondre automatiquement « ce n'est rien ».

3 réponses attendues

DIFFICILE

Q28 · Une personne refuse sa toilette. Quelle conduite relève d'une négociation respectueuse ?

- ☐ A. Explorer les raisons du refus.
- ☐ B. Imposer le soin pour respecter l'horaire.
- ☐ C. Présumer que tout refus est un manque de coopération.
- ☐ D. Ne pas chercher à comprendre les raisons du refus.
- ☐ E. Chercher une option adaptée si possible.

2 réponses attendues

MOYEN

Q29 · Quels éléments peuvent entrer dans un entretien de négociation ?

- ☐ A. Une recherche de compromis.
- ☐ B. Refuser d'expliquer ce qui est négociable dans le cadre du soin.
- ☐ C. Des éléments permettant une décision éclairée.
- ☐ D. La négation du libre arbitre du patient.
- ☐ E. Une injonction sans explication.

2 réponses attendues

FACILE

Q30 · Dans quelles situations un entretien de recadrage peut-il être approprié ?

- ☐ A. Exclusivement avant une admission.
- ☐ B. Comportement inadapté de l'entourage.
- ☐ C. Management.
- ☐ D. Non-respect d'une règle par le patient.
- ☐ E. Uniquement pour les enfants.

3 réponses attendues

DIFFICILE

Q31 · Quelles propositions distinguent rappel d'une règle et entretien de recadrage ?

- ☐ A. Un entretien de recadrage peut comporter une dimension informative.
- ☐ B. Un rappel ponctuel n'est pas automatiquement un entretien structuré.
- ☐ C. Recadrer signifie nécessairement menacer.
- ☐ D. Tout rappel immédiat d'interdiction est un entretien programmé.
- ☐ E. Un entretien peut expliquer le sens et les limites du cadre.

3 réponses attendues

FACILE

Q32 · Quel est l'objectif principal d'un entretien motivationnel ?

- ☐ A. Imposer une décision à la personne.
- ☐ B. Faire émerger la motivation au changement.
- ☐ C. Il demande de ne jamais explorer l'ambivalence.
- ☐ D. Il exclut toute démarche collaborative avec le patient.
- ☐ E. Garantir un changement immédiat.

1 réponse attendue

MOYEN

Q33 · Que signifie l'ambivalence dans l'entretien motivationnel ?

- ☐ A. La personne peut percevoir des raisons de changer.
- ☐ B. Elle impose d'emblée une sanction.
- ☐ C. Elle peut aussi percevoir des raisons de ne pas changer.
- ☐ D. Le soignant peut aider à explorer ce décalage.
- ☐ E. Elle prouve que la personne ment.

3 réponses attendues

DIFFICILE

Q34 · Dans une situation de consommation problématique, une personne minimise les conséquences. Quelles postures sont adaptées ?

- ☐ A. Affirmer que le patient ment obligatoirement.
- ☐ B. Permettre au patient de confronter son vécu à ses objectifs.
- ☐ C. Accueillir sans jugement les contradictions apparentes.
- ☐ D. Poser des questions ouvertes sur les conséquences vécues.
- ☐ E. Décider du changement à sa place.

3 réponses attendues

DIFFICILE

Q35 · Quelles distinctions entre soutien et entretien motivationnel sont correctes ?

- ☐ A. Le motivationnel interdit toutes questions ouvertes.
- ☐ B. Le soutien peut accueillir une émotion difficile.
- ☐ C. Le motivationnel vise l'exploration d'un changement de comportement.
- ☐ D. Encourager quelqu'un à garder espoir suffit à définir le motivationnel.
- ☐ E. Il rend l'écoute incompatible avec le changement.

2 réponses attendues

Déroulement en cinq étapes

FACILE

Q36 · Quelle étape précède l'échange avec la personne soignée ?

- ☐ A. La conclusion.
- ☐ B. La transmission.
- ☐ C. Le remerciement.
- ☐ D. La préparation.
- ☐ E. Le débriefing.

1 réponse attendue

FACILE

Q37 · Que planifier lors de la préparation ?

- [ ] A. Le lieu.
- [ ] B. L'émotion future exacte du patient.
- [ ] C. Maintenir le lieu prévu même si son adaptation est nécessaire.
- [ ] D. Toutes les réponses qu'il donnera.
- [ ] E. Le moment.

2 réponses attendues

MOYEN

Q38 · Quels éléments sont attendus à l'ouverture / orientation ?

- [ ] A. Présenter sa fonction.
- [ ] B. Passer immédiatement à des questions intimes sans cadre.
- [ ] C. Omettre systématiquement la durée.
- [ ] D. Rechercher la disponibilité et l'accord du patient.
- [ ] E. Annoncer l'objectif.

3 réponses attendues

MOYEN

Q39 · Quels outils favorisent l'exploration dans le corps d'un entretien ?

- [ ] A. Interruption automatique de tout silence.
- [ ] B. Écoute active.
- [ ] C. Interdire toute reformulation.
- [ ] D. Il proscrit l'observation des expressions non verbales.
- [ ] E. Jugement de valeur.

1 réponse attendue

DIFFICILE

Q40 · À propos des silences pendant l'exploration, que retenir ?

- [ ] A. Ils doivent être comblés immédiatement.
- [ ] B. Ils imposent toujours la fin de l'entretien.
- [ ] C. Ils peuvent laisser du temps pour exprimer un vécu.
- [ ] D. Ils peuvent avoir du sens.
- [ ] E. Le soignant doit éviter de terminer la phrase du patient.

3 réponses attendues

MOYEN

Q41 · Quelles actions appartiennent à la conclusion ?

- [ ] A. Annoncer la fin.
- [ ] B. Exclure systématiquement toute proposition de rencontre ultérieure.
- [ ] C. Synthétiser l'échange.
- [ ] D. Faire comme si tous les objectifs étaient atteints.
- [ ] E. Éviter de remercier le patient par principe.

2 réponses attendues

DIFFICILE

Q42 · L'objectif d'un entretien n'est atteint que partiellement. Quelles conduites sont cohérentes ?

- [ ] A. Prétendre qu'il est entièrement atteint.
- [ ] B. Évaluer ce qui reste à travailler.
- [ ] C. Le reconnaître dans la synthèse.
- [ ] D. Envisager une suite avec le patient.
- [ ] E. Nier ce qui a été réalisé.

3 réponses attendues

FACILE

Q43 · Après l'entretien, que prévoit l'étape 5 ?

- [ ] A. Il exclut toute transmission écrite après la rencontre.
- [ ] B. L'absence de toute trace de soins.
- [ ] C. La copie intégrale de chaque confidence.
- [ ] D. Un débriefing.
- [ ] E. Des transmissions orales pertinentes.

2 réponses attendues

MOYEN

Q44 · Quelles informations privilégier dans les transmissions ?

- [ ] A. Les jugements personnels sur le caractère du patient.
- [ ] B. Les observations utiles à la continuité du soin.
- [ ] C. Les besoins pertinents identifiés.
- [ ] D. L'intégralité des propos intimes sans sélection.
- [ ] E. Les décisions ou suites convenues.

3 réponses attendues

DIFFICILE

Q45 · Dans le déroulement en cinq phases, quelles associations sont exactes ?

- [ ] A. Évaluation/transmissions : recopier l'entretien mot à mot.
- [ ] B. Préparation : objectifs et modalités.
- [ ] C. Conclusion : ne pas évaluer les objectifs.
- [ ] D. Orientation : cadre et consentement.
- [ ] E. Exploration : écoute et reformulation.

3 réponses attendues

Posture, facilitateurs et freins

FACILE

Q46 · Quels facteurs peuvent favoriser un entretien ?

- [ ] A. Un lieu calme.
- [ ] B. Des interruptions permanentes.
- [ ] C. Des objectifs totalement cachés au patient.
- [ ] D. Proposer la rencontre uniquement lorsque le soignant est indisponible.
- [ ] E. Une posture qui juge systématiquement le patient.

1 réponse attendue

FACILE

Q47 · Quels éléments sont des freins possibles ?

- [ ] A. Une barrière linguistique n'entrave jamais un entretien.
- [ ] B. Une douleur importante.
- [ ] C. Une posture bienveillante.
- [ ] D. L'intimité du lieu.
- [ ] E. Un environnement bruyant.

2 réponses attendues

MOYEN

Q48 · Que peut-on envisager face à une barrière de langue ?

- ☐ A. Reconnaître qu'il s'agit d'un frein possible.
- ☐ B. Remplacer toute explication par des gestes incompréhensibles.
- ☐ C. Supposer automatiquement que l'échange est compris.
- ☐ D. Explorer la possibilité d'un interprétariat.
- ☐ E. Adapter le cadre et les moyens disponibles.

3 réponses attendues

MOYEN

Q49 · Quelles attitudes du soignant favorisent l'entretien ?

- ☐ A. Impatience.
- ☐ B. Une attitude ouvertement irrespectueuse du soignant.
- ☐ C. Congruence.
- ☐ D. Empathie.
- ☐ E. Stigmatisation.

2 réponses attendues

DIFFICILE

Q50 · Une rencontre devient difficile à cause de l'état du patient et du contexte. Quelles adaptations restent cohérentes ?

- ☐ A. Conclure que le patient est forcément de mauvaise volonté.
- ☐ B. Refuser toute aide de l'équipe, quelle que soit la difficulté.
- ☐ C. Réévaluer la disponibilité du patient.
- ☐ D. Poursuivre sans adaptation pour respecter le planning.
- ☐ E. Chercher un lieu plus approprié si possible.

2 réponses attendues

Corrigés argumentés

Fondements et cadres

Q01 — Réponses : C.

Il associe finalité de soin, interaction et expression du patient. La conversation sans but et l'interrogatoire systématique ne définissent pas ce soin. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q02 — Réponses : A, C.

Le formel est programmé et cadré : objectifs, lieu et durée envisagés. La technique et le nombre de participants sont des axes distincts. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q03 — Réponses : D.

L'informel est souvent déclenché sur le moment, par une demande ou un événement. Convocation et planification longue décrivent plutôt le formel. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q04 — Réponses : A, D.

Les catégories individuel et familial décrivent les participants. Directif et semi-directif décrivent une technique ; formel décrit l'organisation.

Q05 — Réponses : A, C, E.

Trois axes de classification distincts décrivent l'organisation, les participants et la technique de conduite. On ne peut pas déduire la technique ni l'organisation des autres axes.

Q06 — Réponses : B, D, E.

Les objectifs possibles comprennent notamment le recueil de données, le soutien et l'accompagnement du changement. L'échange et le respect de la personne demeurent centraux.

Q07 — Réponses : A, E.

L'intention, l'objectif et l'adaptation sont au centre du soin relationnel. Il ne supprime ni l'écoute ni les questions ouvertes. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q08 — Réponses : A, C, E.

Un échange spontané peut être informel, ciblé et informatif à la fois. La planification ne détermine ni les participants ni l'existence d'une finalité.

Q09 — Réponses : B, C, E.

Les appellations sont souples ; une rencontre peut associer plusieurs objectifs tout en gardant une finalité soignante. Le lieu ne détermine pas la technique ; la liste n'est pas exhaustive.

Q10 — Réponses : B, D, E.

Les objectifs et la place du patient restent essentiels, y compris avec la famille. La présence des proches n'autorise pas automatiquement toute divulgation.

Techniques de conduite

Q11 — Réponses : A.

Le directif suit un guidage fort et un objectif ciblé. La liberté continue du discours relève davantage du non-directif. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q12 — Réponses : D, E.

Questionnaires, grilles et audits sont des outils possibles d'une conduite directive. Le directif n'interdit pas l'écoute mais ne se définit pas par l'improvisation. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q13 — Réponses : A, B.

La technique combine un cadre préparé et une exploration ouverte. Elle ne rigidifie pas toutes les relances ni les questions. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q14 — Réponses : A, B, C.

Le patient dispose d'un espace d'expression dans un cadre qui conserve une finalité. Non directif n'équivaut ni à absence de but ni à questions fermées exclusivement.

Q15 — Réponses : C.

« Comment » ouvre à un récit ; les autres formulations appellent plutôt des réponses fermées. Les questions fermées restent utiles au recueil ciblé.

Q16 — Réponses : B.

La question précise et neutre recherche une donnée ciblée. Les réponses suggérées, accusations et cases présumées ne respectent pas le recueil.

Q17 — Réponses : C.

La grille est un appui au questionnement souple et orienté. Elle ne dispense jamais de l'écoute ni de l'adaptation. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q18 — Réponses : A, B, D.

L'expression libre s'appuie sur la maîtrise de l'entretien. Observation et reformulation restent des outils possibles.

Q19 — Réponses : D, E.

Les deux types sont utiles suivant le besoin de recueil ou d'expression. Aucun n'est intrinsèquement sans objectif ou systématiquement inadapté. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q20 — Réponses : B, D, E.

L'entretien libre n'est pas dépourvu de sujet, de finalité ni d'écoute. Silences et thèmes spontanés peuvent apporter des informations utiles.

Objectifs des entretiens

Q21 — Réponses : C.

L'entretien initial peut associer instauration de confiance, exploration des besoins, recueil de données et explications utiles. Il ne réduit pas l'entretien à une information administrative unilatérale. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q22 — Réponses : A, B, D.

Un entretien d'accueil est une finalité de soin ; la phase d'accueil est un temps initial commun aux différents entretiens. Le recueil complet n'est pas obligatoire à chaque ouverture.

Q23 — Réponses : D, E.

L'information peut porter sur l'état de santé, les soins et traitements. L'information doit être adaptée au dialogue, aux questions et aux réactions de la personne.

Q24 — Réponses : A, C, D.

La démarche éducative évalue les acquis et accompagne des apprentissages. Elle va au-delà d'une explication unique.

Q25 — Réponses : C.

La relation d'aide centrée sur la personne suppose empathie, congruence, non-jugement et respect. Stigmatisation et substitution à sa décision s'y opposent. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q26 — Réponses : B, E.

Les outils relationnels incluent notamment exploration, clarification, reformulation et écho. Menace et moquerie s'opposent à la posture requise. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q27 — Réponses : A, B, C.

Le soutien vise l'expression et la compréhension du vécu. Banaliser ou bloquer l'expression ne répond pas à cet objectif.

Q28 — Réponses : A, E.

Le but n'est pas d'obtenir coûte que coûte la toilette à l'heure prévue. La contrainte organisationnelle ne justifie pas à elle seule l'imposition du soin. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q29 — Réponses : A, C.

La négociation recherche une décision éclairée et un compromis possible sans ignorer les limites du cadre de soin. La négociation ne s'assimile pas à l'obtention d'une obéissance. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q30 — Réponses : B, C, D.

Le recadrage peut concerner équipes, patients ou proches selon le cadre. Aucune restriction exclusive aux enfants ou à l'admission n'est formulée.

Q31 — Réponses : A, B, E.

Un rappel immédiat ne constitue pas nécessairement un entretien de recadrage structuré. Le recadrage n'est pas défini par la menace ni par une programmation systématique.

Q32 — Réponses : B.

La démarche est collaborative et centrée sur les ressources propres au patient. Elle ne garantit pas ni n'impose un changement. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q33 — Réponses : A, C, D.

Des motivations opposées peuvent coexister et être explorées. L'ambivalence n'autorise pas un jugement moral.

Q34 — Réponses : B, C, D.

L'entretien motivationnel aide notamment à clarifier progressivement l'ambivalence. Accusation et substitution à la décision sont contraires à la démarche.

Q35 — Réponses : B, C.

La finalité du changement et l'accueil de l'émotion ne sont pas synonymes. Le soutien émotionnel et l'exploration de la motivation ont des finalités différentes.

Déroulement en cinq étapes

Q36 — Réponses : D.

La préparation se déroule sans le patient, avant l'ouverture. Conclusion et transmissions interviennent après le corps de l'entretien.

Q37 — Réponses : A, E.

Les modalités d'organisation sont préparables. Les réactions et réponses futures ne peuvent être décrétées. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q38 — Réponses : A, D, E.

La phase d'orientation comprend présentation du motif, des objectifs, de la durée indicative et vérification de l'accord. L'ouverture construit le cadre plutôt que de le court-circuiter.

Q39 — Réponses : B.

L'exploration mobilise notamment écoute, observation, reformulation et renforcement positif. Respect du silence et non-jugement sont au contraire recherchés. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q40 — Réponses : C, D, E.

Respecter les silences permet au patient de réfléchir et de s'exprimer à son rythme. Un silence n'impose ni clôture systématique ni remplissage immédiat.

Q41 — Réponses : A, C.

La conclusion annonce la fin, fait le bilan et prépare la suite. Elle ne suppose pas automatiquement une atteinte totale des objectifs. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q42 — Réponses : B, C, D.

L'atteinte des objectifs peut être totale, partielle ou absente, ce qui oriente les suites. Il ne faut ni masquer les limites ni annuler les acquis.

Q43 — Réponses : D, E.

Évaluation professionnelle et transmissions font partie du déroulement. La transmission doit être utile et synthétique, et non reproduire tout l'entretien mot pour mot.

Q44 — Réponses : B, C, E.

La transmission sert la continuité de la prise en soins. Les jugements et les détails intimes superflus n'ont pas à figurer dans les transmissions.

Q45 — Réponses : B, D, E.

Les trois premières étapes correspondent à la préparation, à l'orientation et à l'exploration. La conclusion évalue les objectifs ; les transmissions sont sélectives.

Posture, facilitateurs et freins

Q46 — Réponses : A.

Lieu, disponibilité et posture soutiennent l'échange. Opacité et interruptions le fragilisent. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q47 — Réponses : B, E.

Une douleur importante et un environnement bruyant sont deux freins identifiés : ils diminuent la disponibilité ou perturbent la qualité des échanges. La bienveillance et l'intimité favorisent au contraire l'entretien. Une barrière linguistique peut aussi constituer un frein : elle n'est pas toujours sans effet.

Q48 — Réponses : A, D, E.

Une barrière linguistique peut nécessiter un interprétariat adapté pour vérifier la compréhension. La compréhension ne doit pas être présumée.

Q49 — Réponses : C, D.

La congruence, l'empathie et le respect favorisent l'alliance relationnelle et l'écoute. Jugement et impatience font obstacle à l'expression. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.

Q50 — Réponses : C, E.

Adapter le cadre à la disponibilité du patient et solliciter l'équipe si nécessaire aide à réduire les freins. Rigidité et jugement écartent cette approche. Les formulations absolues ou imposées ne décrivent pas une conduite adaptée.